

Guía clínica: Distimia y Depresión Persistente

El trastorno depresivo persistente (distimia) se caracteriza por un estado de ánimo deprimido crónico de baja intensidad. Su cronicidad lo hace especialmente desafiante y muchas veces se naturaliza como 'forma de ser'.

1. Criterios diagnósticos (DSM-5)

- Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante al menos 2 años (1 año en niños/adolescentes).
- Presencia de al menos 2 síntomas: apetito alterado, insomnio/hipersomnia, baja energía/fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse, desesperanza.
- Nunca sin síntomas por más de 2 meses seguidos.
- Deterioro significativo del funcionamiento o malestar clínicamente relevante.

2. Diferencias clave con la depresión mayor

Depresión Mayor	Distimia / TDP
• Episodios claramente delimitados.	• Estado de ánimo deprimido crónico y persistente.
• Síntomas más intensos.	• Síntomas más leves pero constantes.
• Puede haber períodos de eutimia.	• La persona puede no reconocerla como 'enfermedad'.
• Mayor impacto funcional a corto plazo.	• Mayor riesgo de 'doble depresión' (TDM + distimia).

3. El problema de la normalización

Muchas personas con distimia llegan a consulta creyendo que 'así son ellas'. La cronicidad genera una identidad fusionada con la depresión ('soy una persona triste', 'nunca fui feliz'). Uno de los primeros trabajos terapéuticos es separar la persona de la distimia.

4. Características clínicas específicas

- Baja autoestima crónica y autocrítica persistente como rasgo central.
- Desesperanza: sensación de que las cosas nunca van a mejorar.
- Anhedonia leve pero constante: dificultad para disfrutar actividades.
- Funcionamiento social relativamente preservado, lo que puede enmascarar el trastorno.
- Alta comorbilidad con ansiedad, trastornos de la personalidad y TDM.

5. Consideraciones para la intervención

Psicoeducación específica	Diferenciar la distimia de 'cómo soy'. El cambio es posible aunque lleve tiempo. Expectativas realistas.
Activación conductual	Recuperar gradualmente el acceso a refuerzos positivos. Énfasis en consistencia más que en intensidad.
Trabajo en creencias nucleares	La distimia suele tener creencias nucleares profundas ('no valgo', 'no soy querible'). Trabajo más prolongado que en TDM.
Terapia de esquemas	Especialmente útil cuando hay esquemas maladaptativos tempranos. Trabajo en necesidades emocionales no satisfechas.
ACT	Aceptación de emociones dolorosas sin fusionarse con ellas. Acción basada en valores a pesar del estado de ánimo.

6. Señales de progreso en distimia

- El/la paciente empieza a distinguir su identidad de la distimia.
- Pequeños aumentos en la frecuencia de emociones positivas.
- Retoma actividades abandonadas, aunque sea con esfuerzo.
- Reducción de la autocrítica y aumento de la autocompasión.
- Mayor tolerancia a la incertidumbre sobre el futuro.

Notas clínicas

<i>Creencias nucleares identificadas / esquemas predominantes:</i>
<i>Plan de intervención para las próximas sesiones:</i>